

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

Guía rápida para ingreso de casos de Sarampión-Rubéola al sistema VPD-SMART

CIM/OPS

Septiembre 2025

Índice de contenidos

1. Reseña.....	4
2. Glosario, términos y definiciones para el sistema VPD-SMART	5
2.1 Glosarios de siglas.....	5
2.1 Términos y definiciones.....	6
3. Funcionalidades de VPD-SMART.....	7
3.1 Tipos de aplicaciones disponibles en VPD-SMART	7
3.2 Tipos de ingreso de datos.....	7
3.2.1 Ingreso de Caso a Caso o <i>Tracker</i>	7
3.2.2 Ingreso de datos agregados.....	7
3.3 ¿Qué tipo de ingreso de datos se usa en la vigilancia de SR y PFA en VPD-SMART?.....	8
3.4 Nuevas definiciones de importancia	8
3.4.1 Fuente de información poblacional para el cálculo de indicadores.....	8
3.4.2 Reportería a tiempo a OPS	8
4. Secuencia de eventos para la vigilancia epidemiológica de Sarampión y Rubéola en el sistema VPD-SMART	9
4.1 Procedimiento para la asignación de perfiles de usuario en VPD-SMART.....	11
4.2 Ingreso al sistema VPD-SMART	11
4.3 ¿Qué es una unidad organizativa?	14
5. Inscripción: Ingreso de un nuevo caso en el programa: VPD - Sarampión Rubéola	16
5.1 Inscripción.....	16
5.2 Identificación	17
5.3 Información del (de la) paciente	18
5.4 Información de la Institución.....	21
6. ETAPA 1: Vacunación y Datos Clínicos.....	23
6.1 Información básica	23
6.2 Antecedentes de vacunación	24
6.3 Diagnóstico inicial	25
6.4 Datos clínicos	26
6.5 Hospitalización.....	28
6.6 Colección de muestra	29
6.7 Notas.....	30

7. ETAPA 2: Laboratorio	32
7.1 Información básica	32
7.2 Espécimen	33
7.3 Notas	38
8. ETAPA 3: Investigación	38
8.1 Información básica	38
8.2 Investigación	39
8.3 Notas	41
9. ETAPA 4: Medidas de respuesta	42
9.1 Información básica	42
9.2 Medidas de respuesta	42
9.3 Notas	43
10. ETAPA 5: Clasificación	44
10.1 Información básica	44
10.2 Clasificación	45
10.3 Casos con clasificación final de: Sarampión o Rubéola	46
10.3.1 Criterio	46
10.3.2 Contacto	46
10.3.3 Estado	47
10.3.4 Otros comentarios	47
10.3.5 Notas	47
10.4 Casos con clasificación final de: Descartado	47
10.4.1 Criterio	47
10.4.2 Descartado	48
10.4.3 Contacto	48
10.4.4 Estado	48
10.4.5 Otros comentarios	49
10.4.6 Notas	49
10.5 Casos con clasificación final de: Pendiente	49
10.5.1 Descartado	49
10.5.2 Contacto	49
10.5.3 Estado	50
10.5.4 Otros comentarios	50
10.5.5 Notas	50
10.6 Casos con clasificación final: No cumple con la definición de caso	50

10.6.1 Criterio	50
10.6.2 Estado	51
10.6.3 Otros comentarios	51
10.6.4 Notas.....	51
11. Uso de la herramienta <i>Follow Up</i> para el seguimiento de casos.....	51
12. Uso de la función Buscar para localizar casos.	53
13. ¿Cómo editar un caso?	55
14. Función “Completar”: Validación de la información registrada	55
15. Configuración y gestión de alertas en VPD-SMART.....	56

1. Reseña

El sistema *Vaccine Preventable Diseases – Surveillance, Monitoring, Analysis, Reporting and Tracking* (VPD-SMART) es un sistema integral diseñado para la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV), este cuenta con módulos específicos para la vigilancia de Sarampión-Rubéola (SR) y Parálisis Flácida Aguda (PFA). Permite el registro oportuno y el acceso en tiempo real a los datos y análisis de los mismos, mediante el uso de perfiles de usuario individuales con control de acceso.

El nuevo sistema VPD-SMART incluye aplicaciones especializadas para el ingreso, validación, análisis y visualización de la información de las vigilancias. El registro de casos se realiza a través de la aplicación Capturar, donde los datos ingresados se someten automáticamente a reglas de negocio (condiciones predefinidas que verifican campos obligatorios, rangos válidos, coherencia entre variables y formatos permitidos) para asegurar la calidad de la información. Adicionalmente, las aplicaciones analíticas ofrecen tableros y herramientas de exploración que facilitan la interpretación de los datos y apoyan la toma oportuna de decisiones.

Entre sus principales funcionalidades se incluyen: administración de cuentas de usuario, gestión jerárquica de Unidades Organizativas que representan la estructura administrativa del sistema de salud. La organización de la información es a través de Programas, Etapas y Eventos, permitiendo la búsqueda, edición y validación de casos, además de la generación de alertas automáticas que notifican eventos relevantes y facilitan el seguimiento oportuno de los casos.

2. Glosario, términos y definiciones para el sistema VPD-SMART

2.1 Glosarios de siglas

Sigla	Definición
AFP o PFA	Parálisis Flácida Aguda (principal síndrome clínico de la poliomielitis)
App	Programa o conjunto de programas diseñados para realizar tareas o funciones específicas en un dispositivo, como un teléfono móvil, computador o una tablet.
DHIS2	Plataforma de software para recopilar, analizar y compartir datos. Es utilizada por aproximadamente 80 países. El desarrollo es un desarrollo global gestionado por la Universidad de Oslo.
EPV	Enfermedad prevenible por vacunación
NNUU	Naciones Unidas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
ISIS	Antigua plataforma informática para la vigilancia epidemiológica para enfermedades prevenibles por vacunación, llamado así por sus siglas en inglés: <i>"Integrated Surveillance Information System"</i>
SR	Sarampión - Rubéola
SRC	Síndrome rubéola congénita
VPD-SMART	Nuevo sistema informático para la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, llamado así por sus siglas en inglés: <i>"Vaccine Preventable Diseases-Surveillance, Monitoring, Analysis, Reporting and Tracking"</i>

2.1 Términos y definiciones

Término	Definición
Alerta	Correos electrónicos automatizados enviados a usuarios específicos sobre eventos importantes (ejemplo: caso confirmado), configurables en frecuencia y destinatarios.
Capturar o Capture	Aplicación (App) dentro de VPD-SMART utilizada para el ingreso de datos de casos individuales (ejemplo: PFA, SR).
Dato Agregado	Datos resumidos capturados a intervalos regulares (ejemplo: totales semanales de casos).
Dato <i>Tracker</i>	Datos únicos que se pueden seguir a lo largo del tiempo (ejemplo: el historial de un paciente).
Etapas	Fase dentro del flujo de trabajo de un programa (ejemplo: Datos Clínicos y vacunación, Laboratorio, Investigación) alguna etapa puede contener uno o más eventos.
Evento	Ocurrencia específica dentro de una etapa (ejemplo: una toma de muestra dentro de la etapa de Laboratorio).
<i>Follow-up</i>	Función para el seguimiento de un caso a lo largo del tiempo dentro de VPD-SMART.
Grilla	Forma de visualizar datos en filas y columnas, útil para buscar y revisar múltiples casos en VPD-SMART.
<i>Line Listing</i>	App para realizar el listado detallado de casos con información resumida, que permite una visión general y comparación.
Programa	Herramienta dentro de VPD-SMART para la vigilancia de una enfermedad o evento específico (ejemplo: Programa de Sarampión Rubéola, Programa de Parálisis Flácida Aguda).
Semana Epidemiológica	Unidad de tiempo estándar utilizada en epidemiología para la notificación y el análisis de datos de salud, que abarca de domingo a sábado.
Tablero o <i>dashboard</i>	App que presenta datos en forma de indicadores y reportes, facilitando la visualización y el análisis.
Unidad Organizativa	Niveles jerárquicos dentro del sistema (nacional, regional, etc.) que representan la estructura administrativa de salud del país.

3. Funcionalidades de VPD-SMART

3.1 Tipos de aplicaciones disponibles en VPD-SMART

Para facilitar su uso VPD-SMART cuenta con aplicaciones (App). Estas App se pueden agrupar en tres grupos dependiendo de las funciones:

Función	Aplicaciones	Símbolo
Ingreso de datos	Capturar	
Visualización de indicadores y reportes	Tablero	
Visualizaciones personalizadas	Visualizador de Datos	
	Line Listing	
	Mapas	

3.2 Tipos de ingreso de datos

3.2.1 Ingreso de Caso a Caso o Tracker

Es el registro detallado de información individual para cada paciente que cumple con la definición de caso de una de las enfermedades o evento específico sometido a vigilancia. Este método permite analizar características específicas a lo largo del tiempo, pudiendo así investigar brotes, rastrear contactos y evaluar la efectividad de las intervenciones, siendo crucial para enfermedades sujetas a eliminación o erradicación como SR y polio.

3.2.2 Ingreso de datos agregados

Es el reporte consolidado del número total de casos o eventos de una enfermedad dentro de un período y área geográfica definidos, sin incluir detalles individuales de los pacientes. Este método es útil para monitorear tendencias a nivel poblacional, comparar la situación entre regiones y para la planificación de recursos, ofreciendo una visión general más rápida y con menor carga de trabajo.

El sistema VPD-SMART es una herramienta diseñada para la vigilancia de EPV, priorizará la recopilación de datos de caso a caso para las enfermedades clave de eliminación / erradicación. La combinación de ambas metodologías permite una vigilancia epidemiológica robusta y adaptable a las necesidades de cada enfermedad y nivel de atención.

3.3 ¿Qué tipo de ingreso de datos se usa en la vigilancia de SR y PFA en VPD-SMART?

En el sistema VPD-SMART, la modalidad de registro más utilizada es el **ingreso caso a caso** o *Tracker*, lo que permite documentar en detalle cada evento individual. El sistema está diseñado con campos obligatorios y reglas de negocio predefinidas, que aseguran la calidad y consistencia de los datos. Estas reglas impiden avanzar en el proceso de registro si no se completan los campos esenciales, garantizando así que la información ingresada cumpla con los criterios mínimos requeridos para su análisis y seguimiento epidemiológico.

3.4 Nuevas definiciones de importancia

3.4.1 Fuente de información poblacional para el cálculo de indicadores

El sistema VPD-SMART dispone de datos poblacionales precargados con las estimaciones oficiales de Naciones Unidas (NNUU), lo que garantiza una referencia estándar y homogénea para todos los países de la Región. No obstante, el sistema ofrece la opción para que cada país cargue de forma autónoma sus propias estimaciones demográficas, basadas en los censos nacionales u otras fuentes oficiales de carácter interno.

Importante:

Con el objetivo de estandarizar los cálculos de los indicadores regionales de vigilancia, estos serán generados utilizando, de forma predeterminada, las estimaciones poblacionales proporcionadas por las Naciones Unidas, aun cuando los países tengan la posibilidad de cargar sus propios registros demográficos. Por lo tanto, podrían presentarse discrepancias entre los indicadores calculados en el país y los regionales si la población es diferente.

Se recomienda a los países documentar claramente la fuente de población utilizada, a fin de garantizar la trazabilidad, facilitar la comparación entre datos y minimizar posibles interpretaciones erróneas en los análisis regionales.

3.4.2 Reportería a tiempo a OPS

Para los países usuarios de ISIS, OPS WDC registraba semanalmente la fecha de recepción de los reportes correspondientes a las descargas realizadas en el sistema, las cuales eran enviadas por correo electrónico a OPS. Con esta información, era posible calcular un indicador interno denominado “reporte oportuno a OPS”. Sin embargo, para los países que han implementado el nuevo sistema VPD-SMART, el flujo y procesamiento de los datos de

vigilancia se moderniza, al permitir el ingreso descentralizado y en línea por parte de los usuarios, con disponibilidad inmediata de la información a nivel regional una vez validada por el país. Este cambio implica una modificación en el mecanismo para determinar el “**reporte oportuno**”, dado que ahora se trata de un sistema en línea.

Para la obtención del **indicador interno: “reporte oportuno a OPS”** se considerará el ingreso de la variable “**unidades notificadoras que reportan a tiempo**”, la que se ingresa en App “Entrada de datos agregados (Beta)” o que hayan “**completado o modificado datos**” los casos en VPD-SMART (esta acción genera el envío del caso a OPS). Para los países usuarios de ISIS, se continua considerando el envío semanal de la descarga. Para los países que intercambian datos en formato DEF se considerará el envío oportuno.

Importante:

Para el indicador interno denominado “reporte oportuno a OPS”, se considerará en que el país cumple con este criterio si realiza una de las siguientes tres 3 acciones:

- Ingreso el dato de unidades notificando a tiempo en la semana analizada.
- Modificar algún caso en VPD-SMART durante la semana analizada (SR o PFA).
- Completar algún caso en VPD-SMART durante la semana analizada (SR o PFA).

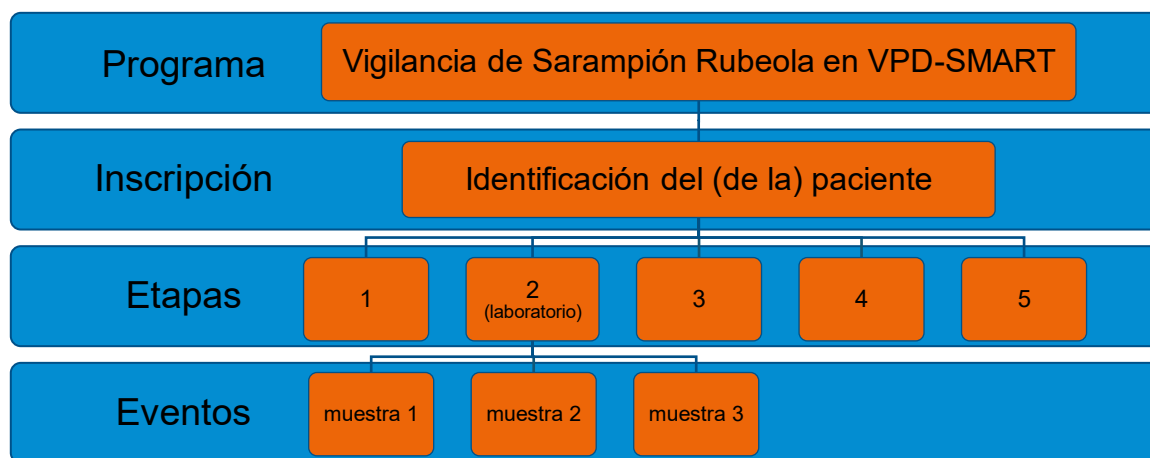
4. Secuencia de eventos para la vigilancia epidemiológica de Sarampión y Rubéola en el sistema VPD-SMART

Para iniciar el proceso de registro, es imprescindible que los digitadores cuenten con un perfil personal e intransferible. Estos perfiles se asignan conforme a las funciones específicas que desempeñarán en el proceso de vigilancia, existiendo diferentes tipos de perfiles con autorizaciones particulares, acorde a sus responsabilidades dentro de la secuencia de eventos.

Comprender la secuencia de eventos que intervienen en el registro de un caso sospechoso de Sarampión-Rubéola (SR) en el sistema VPD-SMART es fundamental para garantizar una adecuada gestión de la vigilancia. Este proceso se estructura con inscripción del caso, luego cinco etapas consecutivas, cada una definida como una fase clave dentro del ciclo de vigilancia epidemiológica. Dichas etapas representan los pasos metodológicos y operativos necesarios para el registro y análisis del caso. A continuación, se describen las cinco **etapas** que conforman la vigilancia epidemiológica de SR en VPD-SMART, además de la indentificación del caso.



Es importante considerar que algunas etapas pueden estar conformadas por múltiples eventos; en particular, la etapa de laboratorio puede incluir varias muestras, las cuales deben registrarse en su totalidad para garantizar la integridad del proceso.



Una vez definidas las funciones de los actores clave en el proceso de vigilancia y notificación de casos sospechosos, así como las etapas en que se estructura dicho proceso, es posible iniciar el trabajo directamente en la plataforma.

4.1 Procedimiento para la asignación de perfiles de usuario en VPD-SMART

Para garantizar el acceso y la correcta gestión dentro del sistema VPD-SMART, cada punto focal nacional es responsable de solicitar la creación de perfiles de usuario para el personal autorizado en su país.

Para solicitar la creación de un nuevo perfil, el punto focal debe enviar un correo electrónico a vpd-support@paho.org la siguiente información detallada para cada persona a la que se le asignará un perfil:

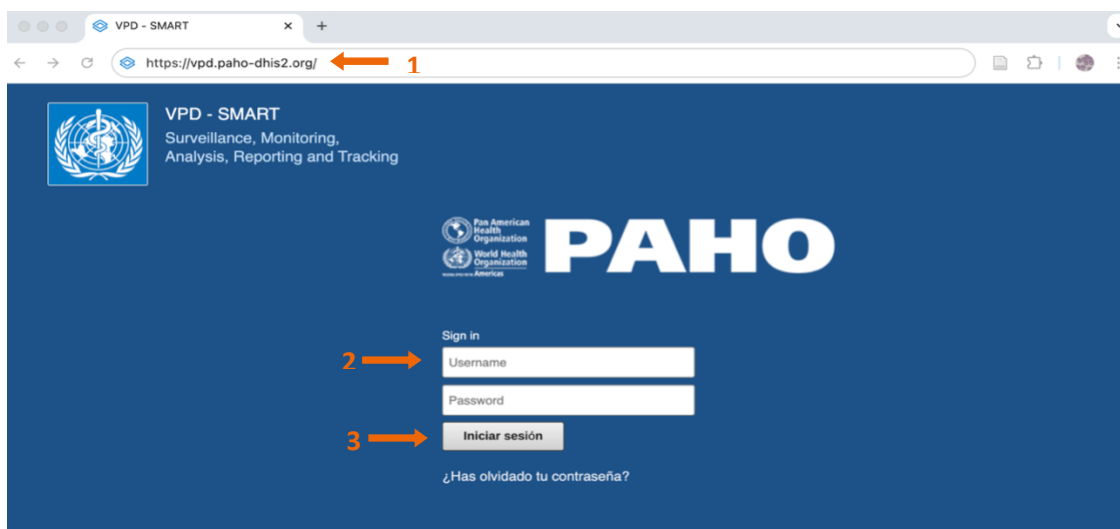
- Documento Nacional de Identidad (DNI): Número de identificación oficial del usuario.
- Nombre: Nombre(s) completo(s) del usuario.
- Apellidos: Apellidos completo(s) del usuario.
- Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico institucional del usuario.
- Tipo de Perfil: Especificar el tipo de perfil de usuario que se debe asignar (ejemplo: Administrador Nacional, Vigilancia a Nivel Nacional, Nivel Regional, Nivel Local, Laboratorio, etc.), de acuerdo con los roles definidos en la estructura de VPD-SMART.

Una vez recibido el correo electrónico con la información completa, el equipo de administración de VPD-SMART procesará la solicitud y notificará al punto focal una vez que los perfiles hayan sido creados y estén activos.

Una vez que los perfiles estén activos podrán ingresar al sistema.

4.2 Ingreso al sistema VPD-SMART

1. Ingrese a su navegador de elección (Chrome, Edge, Safari etc), digite la dirección URL: <https://vpd.paho-dhis2.org>
2. Ingrese su usuario y contraseña
3. Hacer click en “iniciar sesión”



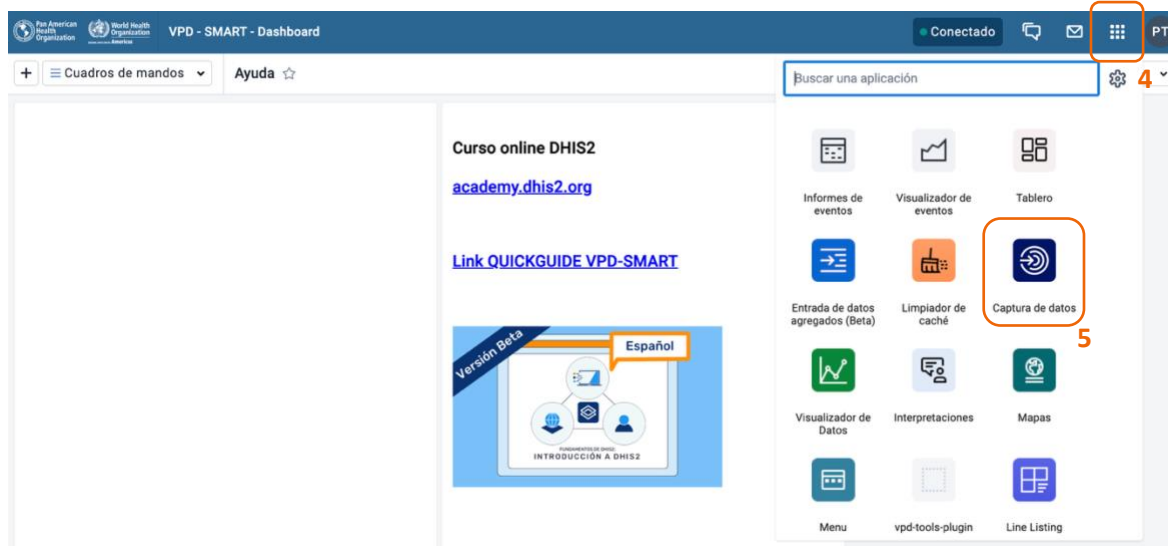
Cómo se mencionó anteriormente los casos **sospechosos de SR** deben ser ingresados bajo el tipo de ingreso **Caso a Caso o Tracker** para poder generar su respectivo seguimiento.

Para iniciar el registro debe seguir los siguientes pasos:

4. Ingrese al set de aplicaciones disponibles



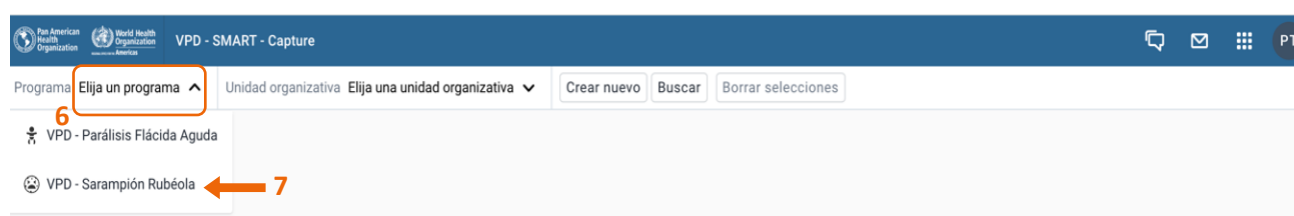
5. Ingresar a la App Captura de datos



6. Seleccione: “Elija programa”

7. Seleccione: “VPD-Sarampión Rubéola”

Los programas son las herramientas que dispone VPD-SMART para la vigilancia de alguna enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. Esta selección determinará el formulario y las etapas específicas que se habilitarán para el registro del caso. Por el momento existen dos programas en VPD-SMART: Sarampión Rubéola (SR) y Parálisis flácida Aguda (PFA).



Para continuar con el registro de un caso sospechoso de SR se deben cumplir las cinco **etapas**. Las etapas representan los diferentes pasos metodológicos y operativos que se siguen para procesar y analizar un caso.

Una vez que se ingrese al programa “VPD-Sarampión Rubéola” debe seguir los siguientes pasos:

8. Seleccione “Elija una unidad organizativa”.

9. Dentro del listado desplegable, seleccione la unidad organizativa más baja a la que está asociado el caso.

10. Seleccione “Crear nuevo caso”.

* Al agregar un nuevo caso es importante verificar que no haya una unidad organizativa cargada previamente por un registro anterior, debido a que queda guardada información del último caso registrado, es necesario borrar los registros previamente guardados del caso anterior, para eso debe hacer click “Borrar selecciones” (11*).

The screenshot shows the 'VPD - SMART - Capture' interface. At the top, there are buttons for 'Programa', 'VPD - Sarampión Rubéola', 'Unidad organizativa: Elija una unidad organizativa', 'Crear nuevo caso', 'Buscar', and 'Borrar selecciones'. Below these, a search bar labeled '8' contains the text 'Buscar'. A dropdown menu is open, showing a list of organizational units under 'Paraguay'. The list includes 'Alto Paraguay', 'Alto Parana', 'Amambay', 'Asunción', 'Boqueron', 'Boqueron', 'Filadelfia', 'Loma Plata', 'Mariscal José Félix Estigarribia', 'Caaguazú', and 'Caazapa'. An orange arrow labeled '9' points to 'Loma Plata'. An orange box labeled '10' highlights the 'Buscar' button. An orange box labeled '11*' highlights the 'Borrar selecciones' button.

4.3 ¿Qué es una unidad organizativa?

Corresponde a una entidad administrativa o territorial que forma parte de la estructura jerárquica del sistema de salud de un país, y que se utiliza para organizar, registrar y gestionar la información de vigilancia epidemiológica. Los niveles organizacionales del país se ordenan de mayor a menos área territorial siendo primero el nacional, los siguientes niveles dependiendo del país (región, distrito, departamento, parroquia, comuna y finalmente institución salud). Verifique el nombre de la unidad organizativa a la que pertenece, tenga en cuenta que los nombres de algunas unidades organizativas pueden coincidir en distintos niveles subnacionales.

Para ingresar un nuevo caso a VPD-SMART se debe usar la unidad organizativa más baja disponible para su país, asociada al caso que está registrando.

The screenshot shows the 'VPD - SMART - Capture' interface with the 'Unidad organizativa' dropdown set to 'Alto Parana'. The search bar contains the text 'Buscar'. A dropdown menu is open, showing a list of organizational units under 'Paraguay'. The list includes 'Alto Paraguay', 'Alto Parana', 'Dr. Juan León Mallorquín', 'Juan E. O'leary', 'Ñacunday', 'Ciudad del Este', 'Domingo Martínez de Irala', 'Dr. Raúl Peña', 'Hernandarias', 'Iruña', 'Itakry', 'Los Cedrales', 'Mbaracayú', and 'Minga Gauzú'. Four orange arrows point to the following items: 'Paraguay', 'Alto Paraguay', 'Alto Parana', and 'Dr. Juan León Mallorquín', indicating the selection of the lowest available unit.

Es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones clave para garantizar el uso adecuado y eficiente del sistema VPD-SMART. Estas consideraciones abarcan aspectos técnicos, operativos y de calidad de la información, por lo que su correcta aplicación contribuye a mantener la integridad de los datos, optimizar los procesos de vigilancia y facilitar la toma oportuna de decisiones.

Importante

- ⇒ Todos los campos señalados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio y deben ser completados para completar el proceso de registro.
- ⇒ Para aquellos campos que requieren ingresar fechas, se dispone de un calendario desplegable desde el cual se podrá seleccionar la fecha correspondiente. Sin embargo, es posible ingresar la fecha manualmente, siguiendo el formato: DD-MM-AAAA.
- ⇒ Por motivos de seguridad y para preservar la integridad de la información, el sistema VPD-SMART **cerrará automáticamente** la sesión si detecta un período de **inactividad** de **15** minutos.
- ⇒ Este mecanismo aplica a cualquier tipo de ingreso de datos, ya sea a nivel de caso individual o mediante la carga de datos agregados. En caso de cierre de sesión automático, el usuario deberá volver a ingresar sus credenciales (usuario y contraseña) para acceder nuevamente a la plataforma.
- ⇒ Se recomienda **guardar periódicamente la información** en proceso para evitar la pérdida de datos no registrados.
- ⇒ Las variables subrayadas en este manual, si bien, no son obligatorias, hacen parte de los indicadores de SR. Por lo tanto, asegure la completitud de esta información.

5. Inscripción: Ingreso de un nuevo caso en el programa: VPD - Sarampión Rubéola

Las variables de la inscripción de un nuevo caso son las siguientes:

5.1 Inscripción

-* **Fecha del inicio del exantema**¹: Introduzca la fecha cuando se inició la aparición del exantema. Se desplegará un calendario indicando la fecha actual, esta puede ser modificada. Verifique la precisión de la fecha del inicio del exantema. Considere que, aunque la presencia del exantema es indispensable para introducir un caso en el sistema de vigilancia, el 50% de los casos de rubéola pueden ser asintomáticos.

-* **Fecha de notificación local**²: Introduzca la fecha de la notificación del caso por el establecimiento de salud al nivel superior en el sistema de vigilancia (por ejemplo, municipio). Esta fecha puede coincidir con la fecha de consulta y con la fecha de notificación nacional.

El programa VPD-SMART cuenta con reglas de negocio integradas para asegurar la calidad de los datos ingresados. Específicamente, las fechas de inicio del exantema y de notificación local deben ser posteriores a la fecha de nacimiento del paciente. Si las fechas ingresadas no cumplen con esta condición, el sistema alertará al usuario para corregir los datos antes de continuar

.

¹ La fecha de inicio de exantema hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada. También, esta fecha se usa para calcular el indicador de porcentaje de casos con muestra adecuada de sangre, es decir, si la muestra fue recolectada dentro de los 30 días después del inicio del exantema.

² Esta fecha es fundamental para el cálculo del indicador de investigación adecuada, ya que permite verificar si la visita domiciliaria se realizó dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. Asimismo, forma parte de las variables clave en el registro de un caso sospechoso y se incluye en la medición del indicador correspondiente.

5.2 Identificación

Las variables son las siguientes:

Programa VPD - Sarampión Rubéola * ▼ Unidad organizativa Puerto Casado * ▼ Crear nuevo caso ▼ Buscar ▼ Borrar selecciones

Nuevo caso en el programa : VPD - Sarampión Rubéola

Inscripción

Fecha de inicio del exantema * 01-04-2025 X

Fecha de notificación local * dd-mm-yyyy X

Identificación

Código de registro ⓘ MR_PRY_1702_

ID de caso de sarampión o rubéola * ⓘ

Información del (de la) paciente

Tipo de identificación ⓘ

Número de identificación ⓘ

Nombre(s)

Apellido(s)

Sexo ⓘ

Nombre de la madre; padre o cuidador ⓘ

- **Código de registro:** Este campo es asignado de manera automática por el sistema (sigla del programa_sigla país_región_código interno del sistema).

- *** ID de caso de sarampión o rubéola³:** Identificador único e irrepetible asignado al caso, se sugiere usar el año como prefijo, sin embargo, es decisión del país la nomenclatura utilizada.

³ Este dato es crucial para asegurar la identificación única del caso, evitar duplicidades y garantizar la trazabilidad durante todo el proceso de vigilancia.

5.3 Información del (de la) paciente

Las variables son las siguientes:

- **Tipo de identificación:** Se debe seleccionar a qué clase de documento corresponde el número de la identificación del caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Número Seguro Social
- Acta de nacimiento
- Número de identificación nacional (cédula, DNI, RUT, etc.)
- Pasaporte
- Tarjeta de residencia
- Otro
- Desconocido

- **Número de identificación:** Ingrese el número de identificación exactamente como aparece registrado en el tipo de documento disponible.

- **Nombre(s)**⁴: Registrar el o los nombres del caso sospechoso exactamente como aparece en el documento de identificación, en caso de que se encuentre disponible.

- **Apellido(s)**⁴: Registrar el o los apellidos del caso sospechoso exactamente como aparece en el documento de identificación, en caso de que se encuentre disponible.

- **Sexo**⁵: Sexo biológico al nacer del caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Masculino
- Femenino
- Otro

- **Nombre de la madre, padre o cuidador:** Si el caso sospechoso es un menor de edad (no ha cumplido 18 años), introduzca el nombre y apellido de la persona responsable.

- ***Municipio de residencia**⁶: Corresponde a la unidad organizativa de la residencia del caso sospechoso. Se debe seleccionar el municipio en el que reside el caso sospechoso. Este

⁴ El nombre completo (nombre y apellido) hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada.

⁵ El sexo hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada.

⁶ Introducir el nombre del municipio (o su equivalente) donde reside el caso.

campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder van a variar dependiendo del país.

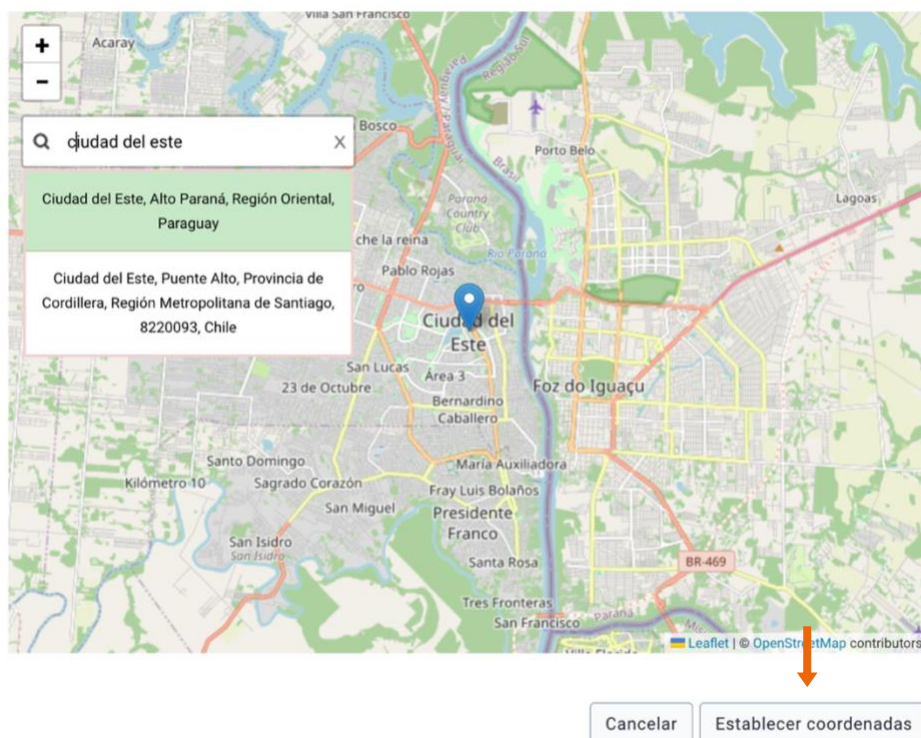
- **Domicilio:** Dirección física de la residencia del caso sospechoso.

- **Coordenadas del domicilio:** Georreferenciación de la dirección física de la residencia del caso sospechoso. El nuevo sistema VPD-SMART permite generar automáticamente la georreferenciación del domicilio del caso, facilitando su ubicación precisa en el mapa. Esta herramienta mejora la eficiencia y precisión en el proceso de asignación y seguimiento de casos, optimizando la gestión de datos geoespaciales. Si no las conoce puede ubicar la residencia del paciente dentro de los mapas precargados en VPD-SMART, para esto debe seleccionar el icono:



Nombre(s)	Gema		
Apellido(s)	Ahumada		
Sexo * ⓘ	Femenino ▼		
Nombre de la madre, padre o cuidador	Carolina Sandoval		
Municipio de residencia *	Ciudad del Este ✕		
Domicilio			
Coordenadas de la dirección		Latitude	Longitude ✕
Referencia adicional del domicilio ⓘ			
¿Se conoce la fecha de nacimiento? *	☒ Si	☐ No	

- **Información para localizar el domicilio:** Se debe proporcionar una descripción detallada de la fachada del domicilio, incluyendo cualquier indicación relevante sobre seguridad o puntos de referencia que faciliten la identificación del lugar. Esta información adicional ayudará a una correcta ubicación del paciente en caso de ser necesario.



-***¿Se conoce la fecha de nacimiento?**⁷: Este campo cuenta con dos opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No

Si la fecha de nacimiento es conocida, se debe seleccionar "**Si**" en el menú, se desplegará la opción de calendario para el ingreso de la fecha de nacimiento.

El sistema VPD-SMART calcula automáticamente la **edad**⁸ al momento del inicio del exantema.

Si la fecha de nacimiento es desconocida, se deberá ingresar la edad del caso sospechoso, tratando de ser lo más preciso posible incluyendo la cantidad de meses, asegurándose de proporcionar la información de la forma más precisa posible.

⁷ La fecha de nacimiento hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada.

⁸ La edad hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada.

5.4 Información de la Institución

Las variables son las siguientes:

- **Nombre de la institución que notifica:** Se debe ingresar el nombre del consultorio, estación médica, unidad de salud u otra institución que notificó el caso sospechoso.

- **Tipo de institución que notifica:** Seleccione la clasificación de la institución que notifica el caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Público
- Privado
- Otros (Otras Instituciones gubernamentales)

- **Notificado por:** Ingrese el nombre y apellido de la persona que realiza la notificación.

- **Teléfono o correo de la persona que notifica:** Digite el número telefónico o correo electrónico que servirá de contacto con la persona a que realizó la notificación del caso.

- **Detectado por:** Corresponde a la fuente de la notificación del caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Servicio de Salud
- Laboratorio
- Búsqueda activa institucional
- Búsqueda activa comunitaria
- Investigación de contactos
- Casos reportados en la comunidad
- Autnotificación por número gratuito
- Otro

- **Fecha de la consulta:** Día exacto en el que se realiza la consulta médica del caso sospechoso ante alguna unidad o institución de salud.

- **Fecha de la notificación nacional:** Fecha en la que el caso es notificado a las autoridades sanitarias al nivel nacional.

- **Fecha de investigación o visita domiciliaria**⁹: Introduzca la fecha cuando se hace la investigación de campo del caso sospechoso, esta coincide con la fecha de la visita domiciliaria.

De manera automática el sistema VPD-SMART identificará las siguientes variables:

- Semana EPI de notificación (basada a partir de la fecha de notificación local).
- Semana EPI de inicio (basada a partir de la fecha del inicio del exantema).
- Año EPI de notificación (basada a partir de la fecha de notificación local).
- Año EPI de inicio (basada a partir de la fecha del inicio del exantema).

Al hacer clic en el botón "Guardar caso" en la parte inferior de la pantalla, se despliegan automáticamente las siguientes etapas correspondientes al caso.

Fecha de consulta ⓘ dd-mm-yyyy

Fecha de notificación nacional ⓘ 24-01-2025

Fecha de investigación o visita domiciliaria 30-01-2025

Tipo de institución que notifica ⓘ Público x ▼

Guardar caso Cancelar

ⓘ Guardando un@ caso en VPD - Sarampión Rubéola en Paso Barreto.

Una vez identificado el caso, se van a desplegar las etapas. Estas aparecerán en su pantalla tal como lo indica la siguiente imagen, para ingresar la información correspondiente a cada etapa se debe seleccionar "Nuevo evento".

⁹ Esta fecha se utiliza en el indicador de investigación adecuada, la visita domiciliaria que debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la notificación.

También, esta fecha hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador.

Esta fecha puede coincidir con la fecha de notificación local si el caso fue detectado por búsqueda de casos en la comunidad, investigación de contactos o auto notificación por número gratuito.

Etapas y eventos

Vacunación y Datos Clínicos
0 eventos

+ Nuevo evento Vacunación y Datos Clínicos

Laboratorio
0 eventos

+ Nuevo evento Laboratorio

Investigación
0 eventos

+ Nuevo evento Investigación

Medidas de respuesta
0 eventos

+ Nuevo evento Medidas de respuesta

Clasificación
0 eventos

+ Nuevo evento Clasificación

6. ETAPA 1: Vacunación y Datos Clínicos

Las variables de esta etapa son las siguientes:

6.1 Información básica

- ***Fecha de registro:** Corresponde a la fecha en la que se inicia la digitación de esta etapa en el formulario.
- ***Unidad Organizativa:** Ingrese la entidad territorial más baja a la que asocia la institución de salud que está notificando el caso. Esta se completa de manera automática, sin embargo, debe verificar su completitud con la información correspondiente al caso.

6.2 Antecedentes de vacunación

Las variables son las siguientes:

- ***¿El (la) paciente está vacunado contra sarampión y rubéola?¹⁰**: Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente de vacunación)

Si la respuesta seleccionada es "**Si**", se desplegará automáticamente una serie de preguntas adicionales asociadas a la vacunación. Estas preguntas permitirán obtener información más detallada sobre el estado de vacunación del caso.

- **Fuente de información sobre la vacunación**: Corresponde al origen de los datos utilizados para verificar el historial de vacunación del paciente. Esta información es clave para evaluar la validez del antecedente vacunal. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Registro de vacunación electrónico: Información obtenida desde un sistema digital oficial.
- Tarjeta de vacunación: Información registrada en el documento físico del paciente.
- Verbal: Información proporcionada por el propio paciente o su familiar, sin respaldo documental.
- Establecimiento de salud: Información recuperada a través de registros internos del centro de salud.
- Desconocido: Cuando no se cuenta con ninguna fuente confiable de información vacunal.

- **Si conoce la institución vacunadora; especificarla**: Introduzca el nombre de la institución donde se vacunó el caso sospechoso.

- **Tipo de vacuna para la última dosis**: Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- SRP: Sarampión Rubéola Paperas
- SR: Sarampión Rubéola
- SRPV: Sarampión Rubéola Paperas Varicela

¹⁰ Permite evaluar el estado de inmunización, clasificar el caso y definir acciones de control.

- Otro

- **Número de dosis de vacuna contra sarampión-rubéola:** Las opciones disponibles en el menú desplegable son:

- 1
- 2
- 3
- 4 o más
- Sin datos (no se cuenta con la información)
- Desconocido (es posible que tenga alguna dosis de vacuna, pero no existe precisión de dosis o fechas de inoculación)

- **Fecha de la última dosis de vacuna contra sarampión-rubéola¹¹:** Ingresar la fecha exacta de la aplicación de la vacuna más reciente.

- **Días entre fecha inicio exantema y fecha última dosis:** Se indica la cantidad de días entre estos dos eventos. El sistema VPD-SMART lo calculará automáticamente a partir de la fecha de inicio de exantema y fecha de la última dosis de vacuna.

Si en la pregunta: “¿El (la) paciente está vacunado contra sarampión y rubéola?” se digitan las respuestas: “No” o “Desconocido” no se desplegarán preguntas adicionales.

6.3 Diagnóstico inicial

Las variables son las siguientes:

- **Diagnóstico inicial:** Este campo cuenta con respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Sarampión
- Rubéola
- Dengue
- Zika
- Chikungunya
- Otra enfermedad febril-exantémica
- Otro

¹¹ El programa VPD-SMART cuenta con reglas de negocio integradas para asegurar la calidad de los datos ingresados. Específicamente, la fecha de vacunación no podrá ser previo a la fecha de nacimiento.

6.4 Datos clínicos

Esta sección tiene como objetivo recopilar información detallada sobre las manifestaciones clínicas presentadas en el caso sospechoso. Permite caracterizar el cuadro clínico y evaluar la presencia de signos y síntomas clave para el diagnóstico, así como identificar posibles complicaciones asociadas.

Datos clínicos	
Fiebre	Si ✕ ▼
Fecha de inicio de la fiebre	07-07-2025 ✕
Exantema	Si ✕ ▼
Tipo de exantema	Maculopapular ✕ ▼
Fecha de inicio del exantema	10-07-2025 ✕
Tos	Desconocido ✕ ▼
Conjuntivitis	No ✕ ▼

- **Fiebre**¹²: Se debe registrar la presencia o ausencia de fiebre. La fiebre constituye uno de los signos cardinales en la presentación clínica de SR, su registro es esencial para la evaluación sindrómica y la clasificación del caso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente)

Si la respuesta seleccionada es "**Si**", se desplegará una nueva pregunta para el ingreso de la fecha exacta del día de inicio de la fiebre, se debe procurar ser lo más exacto posible en el ingreso de la fecha.

¹² La presencia de la fiebre hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada.

- **Exantema**¹³: Indicar la presencia o ausencia de este signo clínico en el caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente)

Si la respuesta seleccionada es "**Si**", se desplegará una nueva pregunta para la caracterización del tipo de exantema

- **Fecha inicio de exantema**¹⁴: Este dato aparecerá como autocompletado con la información ingresa en la primera etapa.

- **Tipo de exantema**: Se debe registrar la clasificación del exantema. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Maculopapular
- Otro
- Desconocido

Los siguientes síntomas y signos deben ser evaluados y registrados en el sistema VPD-SMART. Todas estas variables cuentan con respuestas autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente)

- **Tos**: Expulsión forzada de aire a través de la boca, generalmente provocada por irritación de las vías respiratorias.

- **Conjuntivitis**: Inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre la parte interna de los párpados y la superficie del globo ocular. Se manifiesta clínicamente por enrojecimiento ocular, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño.

¹³ Aunque la presencia del exantema es indispensable para introducir un caso en el sistema de vigilancia, el 50% de los casos de rubeola pueden ser asintomáticos.

¹⁴ La fecha de inicio de exantema hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada. También, esta fecha se usa para calcular el indicador de porcentaje de casos con muestra adecuada de sangre, es decir si la muestra fue recolectada dentro de los 30 días después del inicio del exantema.

- **Coriza:** Inflamación de la mucosa de las fosas nasales, que se manifiesta por secreción nasal (rinorrea), congestión, estornudos y, ocasionalmente, picazón.
- **Manchas Koplik:** Lesiones pequeñas, puntiformes, de color blanco con base eritematosa (rojiza), que aparecen en la mucosa bucal, generalmente en la cara interna de las mejillas, a la altura de los molares. La presencia de manchas de Koplik es común en los casos de sarampión.
- **Artralgia:** Dolor articular sin evidencia clínica de inflamación.
- **Linfadenopatía:** Aumento anormal del tamaño de linfonódulos.
- **Complicaciones:** Corresponde a las condiciones clínicas que se presentan como consecuencia de la infección por SR y que agravan o prolongan la evolución del cuadro clínico. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:
 - o Neumonía
 - o Encefalitis
 - o Diarrea
 - o Trombocitopenia
 - o Otitis media aguda
 - o Ceguera
 - o No tuvo complicaciones
 - o Otro (al seleccionar esta opción se despliega un campo abierto para completarlo manualmente).

Si el caso sospechoso corresponde a una persona de sexo femenino cuya edad sea superior a diez años, se incorporará la pregunta relativa a la condición de embarazo, con las posibles respuestas: “Sí”, “No” o “Desconocido”. Adicionalmente, se incluirá el campo correspondiente a las semanas de embarazo.

6.5 Hospitalización

Las variables son las siguientes:

- **Número de historia clínica:** Identificador único e irrepetible asignado al historial médico del caso.
- **El (la) paciente esta o estuvo hospitalizado (a):** Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:
 - o Si
 - o No

- Desconocido (si desconoce el antecedente)

Si la respuesta seleccionada es "**Si**", se desplegará automáticamente una serie de preguntas adicionales asociadas a la hospitalización.

- **Fecha hospitalización:** Indicar la fecha en la que se inicia la hospitalización del caso sospechoso.

- **Nombre del hospital:** Digite el nombre oficial y completo del establecimiento de salud donde se realizó la hospitalización del caso. Se recomienda no utilizar siglas, abreviaturas ni denominaciones no oficiales, a fin de garantizar una adecuada identificación y trazabilidad de la institución.

- **El (la) paciente está o estuvo aislado:** Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente)

Si la respuesta seleccionada es "**Si**", se desplegará automáticamente una serie de preguntas asociadas a las fechas en las que se realizó la aislación del caso.

- **Fecha de inicio del aislamiento**

- **Fecha que terminó el aislamiento**

Para las dos variables digite la fecha en el calendario precargado en el sistema.

6.6 Colección de muestra

Las variables son las siguientes:

- * **¿Se obtuvo muestra para diagnóstico de laboratorio?:** Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido (si desconoce el antecedente)

6.7 Notas

Este campo está ubicado en la parte final de la etapa, es posible ingresar información adicional que no esté contenida en el formulario, este es un campo libre. Para guardarlo debe indicar “**Añadir nota**”.

Las notas se podrán ver en el panel inicial del caso en el que aparecen todas las etapas de la vigilancia incluidas en el programa de SR. En la imagen se incluye el ejemplo de una nota agregada en la “etapa dos: vacunación y datos clínicos”.

Para continuar con el registro del caso existen tres opciones

Guardando en Vacunación y Datos Clínicos para VPD - Sarampión Rubéola en Puerto Casado

- **Completo:** toda la información incorporada de manera correcta además de revisada.
- **Guardar sin completar:** se han digitado de manera parcial los datos en esta etapa.
- **Cancelar:** elimina todos los datos digitados en la etapa.

La opción “**Completar**” guarda el registro de datos y, una vez que el formulario contiene toda la información requerida, elimina la necesidad de una validación posterior por un nivel administrativo superior, permitiendo la transferencia directa de la información a OPS WDC.

Al seleccionar la opción **Cancelar**, el sistema genera automáticamente una ventana emergente de confirmación:



Esta acción tiene como finalidad garantizar que la operación a realizar corresponde efectivamente a la intención del usuario responsable del ingreso de datos. La ventana de confirmación presenta un mensaje claro e inequívoco, solicitando la validación de la decisión antes de proceder. Esta funcionalidad busca prevenir errores involuntarios y asegurar la integridad de la información registrada en el sistema.

La opción recomendada es **Guarda si completar**, debido a que esta opción guarda los datos registrados en esta etapa, además permite que el nivel administrativo superior pueda confirmar los datos ingresados y transferirlos a OPS WDC, al guardar estos datos se abre la siguiente etapa.

7. ETAPA 2: Laboratorio

Esta es la única etapa del formulario en la que es posible registrar más de un evento. Cada análisis realizado será considerado y registrado como un evento independiente. A continuación, se describen las variables correspondientes a esta sección.

7.1 Información básica

- ***Fecha de registro:** Corresponde a la fecha en la que se inicia la digitación de esta etapa en el formulario.
- ***Unidad Organizativa:** Ingrese la entidad territorial más baja a la que asocia la institución de salud que está notificando el caso. Esta se completa de manera automática, sin embargo, debe verificar su completitud con la información correspondiente al caso. Este dato viene precargado.



Laboratorio

Informe

Programado

Información básica	
Fecha de registro *	dd-mm-yyyy X
Unidad organizativa *	Bella Vista X
Especimen	
① Especimen	
Tipo de muestra	
Fecha de obtención de la muestra	dd-mm-yyyy X
Fecha de envío al laboratorio	dd-mm-yyyy X
Laboratorio que procesa la muestra ①	
Fecha de recepción	dd-mm-yyyy X
ID de la muestra	

7.2 Espécimen

- **Tipo de muestra:** Corresponde a la clasificación del material biológico recolectado para análisis de laboratorio, con el fin de confirmar o descartar el diagnóstico del caso sospechoso de SR. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Suero
- Aspirado/Hisopado Faríngeo o Nasofaríngeo
- Orina
- Tejido

La selección del tipo de muestra es fundamental, ya que determina los análisis que se desplegarán en las preguntas siguientes del formulario. Solo se habilitarán aquellos estudios de laboratorio que correspondan al tipo de muestra indicada.

- **Número de muestra:** Corresponde al orden secuencial de las muestras recolectadas para análisis de laboratorio durante la investigación del caso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Primera
- Segunda
- Tercera
- Cuarta

- **Fecha de recolección de la muestra**¹⁵: Corresponde al día en que se obtuvo la muestra biológica del caso sospechoso para su análisis en laboratorio. Esta información es esencial para el seguimiento de los tiempos de recolección y procesamiento de las muestras, lo que permite una adecuada gestión y monitoreo del caso.

- **Fecha de envío al laboratorio**¹⁶: Día exacto en el cual la muestra biológica, relacionada con el caso de sospechoso, es enviada al laboratorio para su procesamiento y análisis.

¹⁵ La fecha de recolección de la muestra de sangre hace parte de las variables claves de un caso sospechoso, y su registro se considera en el cálculo del indicador de investigación adecuada. Además, se usa para calcular los siguientes indicadores: porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada, y porcentaje de muestras recibidas en el laboratorio dentro de los 5 días posteriores a su obtención.

Este campo cuenta con regla de validación para asegurar que no esté en blanco ni que la fecha de obtención de muestra debe ser posterior a la fecha de inicio del exantema.

¹⁶ Este campo cuenta con regla de validación para asegurar que la fecha de envío a laboratorio debe ser posterior a la fecha de toma de muestra.

- **Laboratorio que procesa la muestra:** Seleccione la categoría del laboratorio al que es derivada la muestra. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Nacional
- Subnacional
- Internacional de Referencia

- **Fecha recepción de la muestra¹⁷:** Fecha en la que el laboratorio recibe la muestra para su análisis.

- **ID de la muestra:** Código único asignado a la muestra biológica para su identificación en los procesos de recolección, transporte, registro y análisis en laboratorio. Este identificador permite garantizar la trazabilidad de la muestra y evitar duplicidades o confusiones durante el flujo de vigilancia.

La plataforma VPD-SMART desplegará automáticamente las opciones de análisis pertinentes, determinadas por el tipo de muestra biológica ingresada. A continuación, se detallan el análisis asociado a cada tipo de muestra, considera que las muestras biológicas asociadas a la vigilancia de SR son:

- a) Suero
- b) Aspirado/Hisopado Faríngeo o Nasofaríngeo
- c) Orina
- d) Tejido

a) Suero

Al indicar que la muestra obtenida es suero, se desplegarán las opciones asociadas a la búsqueda de antígenos. Este campo cuenta con una panel de opciones con las siguientes variables:

- Antígeno Sarampión
- Antígeno Rubéola
- Otros antígenos

En cada uno de ellos se analizará la muestra en busca de inmunoglobulinas M y G (IgM e IgG) para cada una de las enfermedades seleccionadas.

¹⁷ Este campo cuenta con regla de validación para asegurar que la fecha de recepción sea posterior a la fecha de envío.

La fecha de recepción de la muestra de sangre se usa para calcular los indicadores de porcentaje de muestras recibidas en el laboratorio dentro de los 5 días posteriores a su obtención; y porcentaje de muestras de sangre con resultados IgM reportados dentro de los 4 días a su llegada al laboratorio.

Especimen	
📌 Especimen	
Tipo de muestra	Suero x ▼
Número de muestra	Primera x ▼
Fecha de obtención de la muestra	09-07-2025 X
Fecha de envío al laboratorio	09-07-2025 X
Laboratorio que procesa la muestra ⓘ	Laboratorio Regional de Referencia x ▼
Fecha de recepción	10-07-2025 X
ID de la muestra	AC-88471

Seleccione el antígeno	
Sarampión	☒ Si
rubéola	☒ Si
Otros antígenos	☒ Si

Los posibles resultados de IgM e IgG de cada una de las enfermedades son las siguientes:

- Negativo
- Positivo
- Muestra inadecuada
- Indeterminado
- No procesado
- Desconocido (sin resultado disponible)

Además, se habilita el campo para ingresar la fecha del resultado del análisis de IgM¹⁸.

En el caso de pruebas con resultado positivo para IgG se desplegarán más opciones asociada al análisis específico de IgG-Sarampión o Rubéola según sea el caso:

- Concentración de anticuerpos IgG-(mUI/mL): campo numérico.
- Resultado de avidéz IgG (Sarampión o Rubéola):
 - Baja afinidad, alta afinidad, indeterminado
- Fecha de resultado de avidéz de IgG (Sarampión o Rubéola)

¹⁸ Este campo incluye regla de validación en el que la fecha de resultado debe ser posterior a la fecha de recepción de la muestra. La fecha de resultado se usa para calcular el indicador de porcentaje de muestras de sangre con resultados IgM reportados dentro de los 4 días a su llegada al laboratorio

Sarampión	
Resultado de IgM-sarampión	Negativo x ▼
Fecha de resultado de IgM-sarampión	12-07-2025 X
Resultado de IgG-sarampión	Positivo x ▼
Concentración de anticuerpos IgG-sarampión (mUI/mL) ⓘ	120
Fecha de resultado de IgG-sarampión	13-07-2025 X
Resultado de avidez IgG-sarampión	Indeterminado x ▼
Fecha de resultado de avidez IgG-sarampión	14-07-2025 X

Rubeola	
Resultado de IgM-rubeola	Negativo x ▼
Fecha de resultado de IgM-rubeola	13-07-2025 X
Resultado de IgG-rubeola	Negativo x ▼
Fecha de resultado de IgG-rubeola	12-07-2025 X

Al solicitar análisis serológicos para otros antígenos se desplegarán opciones para ingresar los resultados de los siguientes virus (donde deben marcar únicamente sin hay un resultado positivo)

- Dengue
- Parvovirus B 19
- Herpes 6
- Enterovirus
- Chikungunya
- Zika
- Otro patógeno (especificar patógeno)

En caso de ser alguno de estos positivos, se debe completar la fecha del resultado y el análisis realizado para determinar la positividad de la muestra, para todos los virus del listado las opciones son:

- RT-PCR
- IgM
- prueba rápida
- Otro
- IgG

b) Aspirado/Hisopado Faríngeo o Nasofaríngeo, orina y tejido

Para muestras de aspirado, hisopado faríngeo o nasofaríngeo se habilitan las opciones de detección viral sarampión o rubéola mediante técnica de RT-PCR, siendo las siguientes opciones y los resultados:

- Negativo
- Positivo
- Positivo - Genotipo A
- Inconcluso
- Invalido
- Muestra inadecuada

Además, se debe registrar la fecha de este resultado¹⁹. En caso de RT-PCR positivo para Sarampión es necesario indicar genotipo y linaje, sin embargo, el linaje se debe seleccionar únicamente si hay genotipo: B3, D4, D5, D6, D8, D9, H1. Para esto se desplegarán las variables asociadas a la genotipificación del virus.

Detección Viral (Sarampión)	
Resultado de RT-PCR sarampión	Positivo x ▼
Fecha de resultado de RT-PCR sarampión	15-07-2025 X
Genotipificación (Sarampión)	
Si se detectó virus del sarampión; especificar genotipo y linaje	x ▼
DSID Sarampión ⓘ	
Linaje	MVs/Tonbridge.GBR/5.14 x ▼
MR-Región secuenciada (Sarampión)	N completo x ▼

Por su parte en el caso de un RT-PCR positivo a rubéola, igualmente debe identificar genotipo del virus.

¹⁹ Este campo incluye regla de validación en el que la fecha de resultado debe ser posterior a la fecha de recepción de la muestra.

Tampoco se permiten fechas en el futuro

Genotipificación (Rubéola)	
Si se detectó el virus de Rubéola; especificar el genotipo	G3 x ▼
MR-DSID Rubéola ⓘ	
VPD-MR-Región secuenciada (rubéola)	Complete genome x ▼

Notas

Escribir nota

Completo

Guardar sin completar

Cancelar

ⓘ Guardando en Laboratorio para VPD - Sarampión Rubéola en Puerto Casado

7.3 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes.

8. ETAPA 3: Investigación

Las variables de esta etapa son las siguientes:

8.1 Información básica

- ***Fecha de registro:** Corresponde a la fecha en la que se inicia la digitación de esta etapa en el formulario.
- ***Unidad Organizativa:** Ingrese la entidad territorial más baja a la que asocia la institución de salud que está notificando el caso. Esta se completa de manera automática, sin embargo, debe verificar su completitud con la información correspondiente al caso.

Investigación

Informe Programado

Información básica	
Fecha de registro *	01-07-2025 x
Unidad organizativa *	Puerto Casado x
Investigación	
¿Se realizó búsqueda activa de casos en la comunidad?	Si x ▼
Número de casos sospechosos identificados en la búsqueda activa comunitaria	8
¿Se realizó búsqueda activa institucional de casos?	Si x ▼
Número de casos sospechosos identificados en la búsqueda activa institucional	13
¿Existen casos confirmados de sarampión o rubeola en el municipio de residencia?	Si x ▼

8.2 Investigación

Las variables son las siguientes:

- **¿Se realizó búsqueda activa de casos en la comunidad?**: La búsqueda activa comunitaria se define como la búsqueda intencionada de casos en la comunidad, realizada retrospectivamente y en un período determinado, dependiendo de la EPV que se esté investigando. El objetivo es la identificación sistemática y proactiva de personas con signos y síntomas compatibles con SR (fiebre y exantema maculopapular, acompañado de tos, coriza o conjuntivitis) a través de visitas en la comunidad y la revisión de diferentes fuentes de información. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **Número de casos sospechosos identificados en la búsqueda activa comunitaria**: Campo numérico que debe indicar la cantidad de casos sospechosos fueron detectados mediante la investigación directa en la comunidad.

- **¿Se realizó búsqueda activa institucional de casos?:** La búsqueda activa institucional se define como la revisión sistemática de historias clínicas en establecimientos de salud públicos y privados, realizada retrospectivamente y en un período determinado para detectar casos que cumplan con la definición de caso sospechoso, el periodo va a depender de la enfermedad prevenible por vacunación (EPV) que se esté investigando. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **Número de casos sospechosos identificados en la búsqueda activa institucional:** Campo numérico que debe indicar la cantidad de casos sospechosos fueron detectados mediante la investigación de historiales clínicos.

- **¿Existen casos confirmados de sarampión o rubéola en el municipio de residencia?:** Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **¿El (la) paciente estuvo en contacto con una mujer embarazada?:** Dentro de la investigación de un caso de sarampión o rubéola, esta información es fundamental para activar de manera inmediata medidas de control, seguimiento y prevención orientadas a reducir la transmisión y proteger la salud materno-fetal. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **¿El (la) paciente viajó fuera de su estado o provincia de residencia en los 7-23 días anteriores al inicio del exantema?:** Esta información es clave porque permite identificar el posible origen de la infección y evaluar el riesgo de diseminación. El periodo de 7 a 23 días corresponde al intervalo de incubación de SR, por lo que un viaje en ese lapso puede indicar exposición fuera del lugar de residencia o vínculo con un brote en otra área geográfica. Además, facilita la clasificación del caso (importado, relacionado con importación o autóctono) y orienta las acciones de búsqueda activa, rastreo de contactos y control en la zona visitada, reduciendo así la transmisión comunitaria.

Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

Si se indica una respuesta afirmativa sobre un viaje en el periodo señalado (7 a 23 días previo al inicio de exantema), se habilitarán los campos para especificar el país y la ciudad del primer destino. En caso de que el paciente haya visitado más lugares, estos deberán registrar de la misma manera, pudiendo ingresar hasta cinco destinos (país y ciudad). Es fundamental completar las fechas de llegada y salida correspondientes a cada uno.

- **Fuente de contagio:** Se refiere al lugar o contexto donde se presume que el caso adquirió la infección. Esta información es clave para identificar los escenarios de transmisión y orientar las acciones de control epidemiológico. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Contacto en el hogar
- Comunidad
- Servicio de Salud
- Evento público masivo
- Institución educativa
- Transporte internacional
- Espacio público
- Otro
- Desconocido

- **Si hay otra fuente de contagio; especificarla:** Si la posible fuente de contagio no está contenida en la pregunta anterior puede digitarla en este campo abierto.

8.3 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes.

9. ETAPA 4: Medidas de respuesta

Las variables de esta etapa son las siguientes:

9.1 Información básica

- ***Fecha de registro:** Corresponde a la fecha en la que se inicia la digitación de esta etapa en el formulario.
- ***Unidad Organizativa:** Ingrese la entidad territorial más baja a la que asocia la institución de salud que está notificando el caso. Esta se completa de manera automática, sin embargo, debe verificar su completitud con la información correspondiente al caso.

 Medidas de respuesta

Informe Programado

Información básica

Fecha de registro *

dd-mm-yyyy



Unidad organizativa *

Bella Vista



Response measures

¿Hubo vacunación de bloqueo? ⓘ

¿Se realizó monitoreo rápido de vacunación?

¿Se le administró vitamina A?

Notas

Escribir nota

Completo

Guardar sin completar

Cancelar

ⓘ Guardando en Medidas de respuesta para VPD - Sarampión Rubéola en Bella Vista

9.2 Medidas de respuesta

- **¿Hubo vacunación de bloqueo?:** La vacunación de bloqueo es una estrategia de vacunación selectiva dirigida a población susceptible que no ha iniciado o completado el

esquema de vacunación contra el sarampión y la rubéola, el cual debe realizarse entre 48 y 72 horas después de la notificación del caso sospechoso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **¿Se realizó monitoreo rápido de vacunación?**: El monitoreo es una herramienta simple y de bajo costo que evalúa de manera rápida e inmediata la proporción de personas vacunadas y personas no vacunadas en una zona determinada mediante la visita casa a casa. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

- **¿Se le administró vitamina A?**: El llenado de esta variable solo aplica a casos confirmados de sarampión. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

Si se indica “Si” se despliega una pregunta extra

- **Número de dosis de vitamina A recibidas**: Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- 1
- 2
- 3
- 4 o más
- Sin datos
- Desconocido

9.3 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes.

10. ETAPA 5: Clasificación

Las variables de esta etapa son las siguientes:

10.1 Información básica

- ***Fecha de registro:** Corresponde a la fecha en la que se inicia la digitación de esta etapa en el formulario.
- ***Unidad Organizativa:** Ingrese la entidad territorial más baja a la que asocia la institución de salud que está notificando el caso. Esta se completa de manera automática, sin embargo, debe verificar su completitud con la información correspondiente al caso.



Clasificación

Informe

Programado

Información básica

Fecha de registro *

dd-mm-yyyy



Unidad organizativa *

Bella Vista



Clasificación

Clasificación final



Fecha de la clasificación final

dd-mm-yyyy



Clasificado por



Criterio

Criterio para la clasificación final



Descartado

Criterio para descartar



10.2 Clasificación

Las variables son las siguientes:

- **Clasificación final:** Usualmente, la clasificación final de un caso sospechoso lo hace el nivel nacional. Por lo tanto, es posible que la información para el llenado de estas variables no esté disponible en el nivel local donde si el registro de los casos se realiza de manera descentralizada en el país. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Sarampión
- Rubéola
- Descartado
- No cumple con la definición de caso
- Pendiente

- **Fecha de la clasificación final:** Día exacto en el que se establece la clasificación final del caso.

- **Clasificado por:** Dependerá del país que instancia es la responsable de determinar la clasificación final de los casos sospechosos. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Programa Nacional de Inmunizaciones
- Dirección de Vigilancia Epidemiológica
- Unidad de análisis
- Comité de expertos
- Otro

Una vez completado el campo “**Clasificación final**”, el sistema habilitará un conjunto de variables condicionales de la respuesta. En las secciones siguientes se describen, los cuatro posibles escenarios generados a partir la clasificación final seleccionada, estas son:

10.3 Casos con clasificación final de: Sarampión o Rubéola

10.4 Casos con clasificación final: Descartado

10.5 Casos con clasificación final: Pendiente

10.6 Casos con clasificación final: No cumple con la definición de caso

10.3 Casos con clasificación final de: Sarampión o Rubéola

10.3.1 Criterio

- **Criterio para la clasificación final:** En esta variable se debe seleccionar el fundamento técnico utilizado para asignar la clasificación definitiva del caso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Laboratorio
- Nexo epidemiológico
- Clínico

- **Fuente de infección de los casos confirmado:** Origen probable del virus que ocasionó la infección en el caso confirmado. Esta variable es clave para identificar dónde o cómo el paciente adquirió la enfermedad. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- **Importado:** Para sarampión si estuvo fuera de su país de origen 7 a 21 días previo al inicio del exantema, o 12 a 23 días anteriores en el caso de rubéola.
- **Relacionado con la importación:** Si adquirió la infección localmente y es parte de una cadena de transmisión iniciada por un caso importado.
- **Fuente desconocida:** Si no se pudo identificar dicha después de una investigación exhaustiva.
- **Endémico:** Si hace parte de una cadena de transmisión endémica, lo que significa que el virus detectado (con el mismo genotipo y linaje) ha estado circulando en el país durante un período de 12 meses o más.

10.3.2 Contacto

- **¿Contacto de otro caso?:** Indicar si en la investigación epidemiológica fue posible determinar que este caso tuvo contacto con un caso previamente detectado. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

Si se indica “**Si**” se despliega una variable extra

- **Número de identificación del caso asociado:** Identificador único e irrepetible asignado al caso confirmado que fue contacto de este caso.

10.3.3 Estado

- **Estado en el momento del alta:** Condición en la que egresa el caso de la vigilancia. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Recuperado
- Fallecido
- Desconocido

En caso de fallecimiento ingresar fecha y causa de defunción²⁰.

10.3.4 Otros comentarios

- **Comentarios:** Campo abierto para indicar información adicional asociada al caso confirmado de sarampión o rubeola según corresponda.

10.3.5 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes

10.4 Casos con clasificación final de: Descartado

10.4.1 Criterio

- **Criterio para la clasificación final:** En esta variable se debe seleccionar el fundamento técnico utilizado para asignar la clasificación definitiva del caso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Laboratorio
- Nexo epidemiológico
- Clínico

- **Fuente de infección de los casos confirmados²¹:** Origen probable del virus que ocasionó la infección en el caso confirmado. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Importado
- Relacionado con la importación
- Fuente desconocida

²¹ Como mecanismo de validación estos campos se activan, solamente si la fuente de infección de los casos confirmados es: Importado

- Endémico

10.4.2 Descartado

- **Criterio para descartar:** Esta variable indica la razón técnica o epidemiológica que justifica la exclusión de un caso previamente notificado como sospechoso. Si se descarta basado en más de un criterio, elija la razón principal. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- IgM-negativo sarampión/rubéola
- Relacionado con la vacuna
- Dengue
- Parvovirus B19
- Herpes 6
- Reacción alérgica
- Otro diagnóstico: indique qué otro diagnóstico

10.4.3 Contacto

- **¿Contacto de otro caso?:** Indicar si en la investigación epidemiológica fue posible determinar que este caso confirmado tuvo contacto con un caso previamente detectado. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

Si se indica “Si” se despliega una variable extra

- **Número de identificación del caso asociado:** Identificador único e irreplicable asignado al caso confirmado que fue contacto de este caso.

10.4.4 Estado

- **Estado en el momento del alta:** Condición en la que egresa el caso de la vigilancia. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Recuperado
- Fallecido
- Desconocido

En caso de fallecimiento ingresar fecha y causa de defunción²².

²² Como método de validación estas variables se activarán solo si se indica estado: fallecido.

10.4.5 Otros comentarios

- **Comentarios:** Campo abierto para indicar información adicional asociada al caso confirmado de sarampión o rubeola según corresponda.

10.4.6 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes.

10.5 Casos con clasificación final de: Pendiente

10.5.1 Descartado

- **Criterio para descartar:** Esta variable indica la razón técnica o epidemiológica que justifica la exclusión de un caso previamente notificado como sospechoso. Si se descarta basado en más de un criterio, elija la razón principal. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- IgM-negativo sarampión/rubéola
- Relacionado con la vacuna
- Dengue
- Parvovirus B19
- Herpes 6
- Reacción alérgica
- Otro diagnóstico: indique qué otro diagnóstico

10.5.2 Contacto

- **¿Contacto de otro caso?:** Indicar si en la investigación epidemiológica fue posible determinar que este caso confirmado tuvo contacto con un caso previamente detectado. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Si
- No
- Desconocido

Si se indica “Si” se despliega una variable extra

- **Número de identificación del caso asociado:** Identificador único e irrepetible asignado al caso confirmado que fue contacto de este caso.

10.5.3 Estado

- **Estado en el momento del alta:** Condición en la que egresa el caso de la vigilancia. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Recuperado
- Fallecido
- Desconocido

En caso de fallecimiento ingresar fecha y causa de defunción²³

10.5.4 Otros comentarios

- **Comentarios:** Campo abierto para indicar información adicional asociada al caso confirmado de sarampión o rubeola según corresponda.

10.5.5 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes

10.6 Casos con clasificación final: No cumple con la definición de caso

10.6.1 Criterio

- **Criterio para la clasificación final:** En esta variable se debe seleccionar el fundamento técnico utilizado para asignar la clasificación definitiva del caso. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Laboratorio
- Nexo epidemiológico
- Clínico

- **Fuente de infección de los casos confirmados:** Origen probable del virus que ocasionó la infección en el caso confirmado. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Importado²³
- Relacionado con la importación²⁴
- Fuente desconocida

²³ Como método de validación estas variables se activarán solo si se indica estado: fallecido.

²⁴ Como mecanismo de validación estos campos se activan, solamente si la fuente de infección de los casos confirmados es: Importado

- Endémico

10.6.2 Estado

- **Estado en el momento del alta:** Condición en la que egresa el caso de la vigilancia. Este campo cuenta con una respuesta autodesplegable, las opciones disponibles para responder son las siguientes:

- Recuperado
- Fallecido
- Desconocido

En caso de fallecimiento ingresar fecha y causa de defunción²⁵

10.6.3 Otros comentarios

- **Comentarios:** Campo abierto para indicar información adicional asociada al caso confirmado de sarampión o rubeola según corresponda.

10.6.4 Notas

Al igual que en las etapas anteriores, es posible ingresar notas mediante campos de texto libre, que permiten complementar la información registrada en los apartados correspondientes.

11. Uso de la herramienta *Follow Up* para el seguimiento de casos.

La herramienta de seguimiento o “*Follow up*” de VPD-SMART permitirá buscar en un caso en específico de forma más rápida una vez que se desee completar la información faltante o revisar la ficha para darle seguimiento a un caso.

Para activar esta opción, usted debe ir al costado derecho de la pantalla ubique en la sección “**Inscripción**” (1) seleccionando la opción “**Acciones de Inscripción**” (2), dentro de esta opción seleccione “**Marcar para seguimiento**” (3).

²⁵ Como método de validación estas variables se activarán solo si se indica estado: fallecido.

Programa VPD - SMART - Capture

Programa VPD - Sarampión Rubéola Unidad organizativa Bella Vista Caso 2025nuevocaso Inscripción 10-07-2025 Etapa Clasificación Fecha de registro

Crear nuevo caso Buscar Borrar selecciones

Program overview > Panel de inscripción > Evento nuevo

Clasificación

Informe Programado

Información básica

Fecha de registro * dd-mm-yyyy

Unidad organizativa * Bella Vista

Clasificación

Clasificación final

Fecha de la clasificación final dd-mm-yyyy

Clasificado por

Inscripción 1

Activo

Fecha de inicio del exantema: 10-07-2025

Fecha de notificación local: 10-07-2025

Comenzó en: Bella Vista

Propiedad de: Bella Vista

Última actualización hace 11 días

Acciones de inscripción

✓ Completo

✗ Marcar para seguimiento

→ Transferir

✗ Marca como cancelado

Borrar

Semana EPI de inicio: 28

Para visualizar los casos en los que se ha habilitado la opción de seguimiento, debe acceder al listado de casos y seleccionar el botón **Follow up**. De este modo, se desplegará en la pantalla el listado completo de todos los casos con seguimiento activo, los que se verán de la siguiente manera:

Programa VPD - Parálisis Fláccida Aguda Unidad organizativa Elija una unidad organizativa

Crear nuevo caso Buscar Borrar selecciones

Follow-up General

Estado de la inscripción. Fecha de inicio de la parálisis Fecha de notificación local Seguimiento: Si Más filtros

ID de caso PFA	Nombre completo	Semana EPI de inicio	Año EPI de inicio	Sexo	Fecha de nacimiento	Edad en meses	Edad en años	Semana EPI de notificación	Año EPI de notificación	Tipo de identificación
0001	Gema Ahumada			Femenino	14-02-2020	11	4			3 - Número de identificación Nacional (Cédula, DNI, RUT, etc.)
PRY-IIN-SVP-24-001	ISMAEL DIAZ ROMAN	33	2024	Masculino	08-11-2014		9	36	2024	3 - Número de identificación Nacional (Cédula, DNI, RUT, etc.)

Para visualizar la totalidad de los casos registrados, desactive la opción **Follow Up** o, alternativamente, seleccione el botón **General**. De este modo, se mostrará el 100% de los casos registrados.

Programa: VPD - Sarampión Rubéola | Unidad organizativa: Elija una unidad organizativa | Crear nuevo caso | Buscar | Borrar selecciones

Follow-up: **General**

Filtros: Estado de la inscripción | Fecha de inicio del exantema | Fecha de notificación local | Seguimiento: No | Más filtros

ID de caso de sarampión o rubéola	Semana EPI de inicio	Año EPI de inicio	Tipo de identificación	Número de identificación	Domicilio	Fecha de nacimiento	Sexo	Código de registro	Detectado por
☐ carmennuevocaso	28	2025	Número Seguro Social	88989			Femenino	MR_PRY_1702_carmennuevocaso	
☐ 2025nuevocaso	28	2025				12-10-1985	Femenino	MR_PRY_1302_2025nuevocaso	
☐ PRY-XI-MRA-25-020	26	2025	Número de Identificación Nacional (Cédula, DNI, RUT, etc.)	91353152	MARIA AUXILIADORA NANAWA ENTRETEOFILO MARTINEZ	17-09-2023	Masculino	MR_PRY_1110_PRY-XI-MRA-25-020	Búsqueda activa institucional
☐ PRY-IV-ITB-25-001	26	2025	Número de Identificación Nacional (Cédula, DNI, RUT, etc.)	9216845	SAN ANTONIO-PORTON DE LOS SUEÑOS Y COSTA RICA	10-11-2017	Femenino	MR_PRY_0409_PRY-IV-ITB-25-001	Servicio de Salud

12. Uso de la función Buscar para localizar casos.

Las herramientas de búsqueda nos permitirán buscar un caso en particular, para visualizar, editar o completar tanto la información de inscripción de un caso y/o de sus etapas.

Existen 2 tipos de búsqueda:

- Botón Buscar
 - Búsqueda por grilla
- a) **Botón Buscar:** Esta función permite localizar un caso específico mediante el uso del botón de búsqueda. Para ello, primero se debe seleccionar el programa correspondiente (VPD-SMART Sarampión – Rubéola) y, de ser posible, indicar la Unidad Organizativa en la que el caso pudo haber sido registrado el caso sospechoso. Una vez

definidos estos criterios, haga clic en el botón *Buscar* para obtener los resultados. Si cuenta con el ID del caso ²⁶ ingréselo para llegar de manera más directa al caso.

The screenshot shows the 'VPD - SMART - Capture' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Programa' (set to 'VPD - Sarampión Rubéola') and 'Unidad de registro' (set to 'Asunción'). To the right are buttons for 'Crear nuevo caso', 'Buscar', and 'Borrar selecciones'. Below these, a search dropdown is open, showing 'Buscar un(a) caso en VPD - Sarampión Rubéola' and 'Buscar...'. A search bar labeled 'Buscar VPD-Código de Registro' is also visible, with a 'VPD-Código de Registro' input field and a 'Buscar por VPD-Código de Registro' button. At the bottom, there is a section for 'Buscar por atributos de'.

- b) Búsqueda en Grilla:** Esta función permite localizar un caso incluso cuando no se conoce el ID del mismo, ya que es posible visualizar un conjunto de casos. Para ello, primero se debe seleccionar el programa correspondiente “VPD- Sarampión Rubéola” (1), luego seleccione “vea todos los registros a los que puede acceder en VPD- Sarampión Rubéola” (2), y de forma automática se desplegará una grilla con todos los casos registrados. Posteriormente, se pueden aplicar diversos filtros para facilitar la búsqueda de un caso en particular. Si el perfil del usuario es nacional, tendrá acceso a la información de todo el país. En cambio, si el perfil es subnacional, únicamente podrá visualizar los casos correspondientes a su nivel administrativo.

The screenshot shows the 'VPD - SMART - Capture' interface. The 'Programa' dropdown is set to 'VPD - Sarampión Rubéola'. The 'Unidad organizativa' dropdown is set to 'Elija una unidad organizativa'. To the right are buttons for 'Crear nuevo caso', 'Buscar', and 'Borrar selecciones'. Below these, a message says 'Seleccione una unidad organizativa.' and a link is provided: 'O vea todos los registros a los que puede acceder en VPD - Sarampión Rubéola'.

²⁶ ID de caso de sarampión o rubéola: corresponde al identificador único e irreplicable asignado al caso, se sugiere usar el año como prefijo, sin embargo, es decisión del país la nomenclatura utilizada (se debe generar al momento de digitar el caso por primera vez en VPD-SMART).

En esta pantalla es posible filtrar por cada de las variables indicadas en la parte superior de la grilla, además de ordenar de manera ascendente o descendente la variable seleccionada.

Programa: VPD - Sarampión Rubéola | Unidad organizativa: Elija una unidad organizativa | Crear nuevo caso | Buscar | Borrar selecciones

Follow-up | General

Filtros: Estado de la inscripción, Fecha de inicio del exantema, Fecha de notificación local, ID de caso de sarampión o rubéola, Más filtros

ID de caso de sarampión o rubéola	Nombre completo	Semana EPI de inicio	Año EPI de inicio	Número de identificación	Sexo	Edad en meses en el momento de inicio del exantema	Edad en años en el momento de inicio del exantema	Semana EPI de notificación	Año EPI de notificación	Código de registro

13. ¿Cómo editar un caso?

Los registros pueden ser editados. Para poder editar la información se deberá usar alguna herramienta de búsqueda y luego seleccionar la etapa del caso que desee editar.

Si se desea editar alguna parte de la identificación del caso se debe hacer en el costado derecho de su pantalla (1).

Si la información a modificar es de alguna de las etapas debe seleccionarla directamente (2).

Luego de editar la información no olvide guardar el cambio realizado.

Datos Clínicos y Vacunación 1 evento(s) | Última actualización hace 12 días

Estado	Fecha de registro	Unidad de registro
Completado	06-11-2018	Concepcion

+ Nuevo evento Datos Clínicos y Vacunación

Laboratorio 4 evento(s) | Última actualización hace 12 días

Estado	Fecha de registro	Unidad de registro	Número de muestra	Tipo de muestra	Fecha de recolección de la muestra	ID de la muestra
Completado	06-11-2018	Concepcion	1	1	06-11-2018	313242

Perfil de Caso

ID de caso MR: 18-656

Nombre completo: RODAS DIEGO SANTINO

Semana EPI de inicio: 44

Año EPI de inicio: 2018

Acciones de inscripción: Editar

14. Función “Completar”: Validación de la información registrada

La función “Completar” permite que el nivel central valide y consolide la información registrada por las unidades organizativas de nivel subnacional (regiones, comunas, departamentos, parroquias, distritos o establecimientos de salud) dentro de la plataforma

VPD-SMART. Esta acción constituye un paso esencial para garantizar la calidad, consistencia y veracidad de los datos, ya que asegura que la información ha sido revisada y aprobada antes de ser enviada a instancias superiores, como OPS WDC.

De este modo, el proceso de completar un caso no solo facilita la revisión jerárquica de la información, sino que también fortalece la integridad del sistema de vigilancia, asegurando que los registros cumplan con los estándares técnicos y epidemiológicos requeridos para el monitoreo y la toma de decisiones a nivel regional e internacional. La acción de completar permitirá a un nivel Central validar la información proporcionada por alguna unidad organizativa inferior.

Para “completar un caso”, acceda al registro, vaya al costado derecho de la pantalla ubique en la sección **“Inscripción”** (1) seleccionando la opción **“Acciones de Inscripción”** (2), dentro de esta opción seleccione **“Completo”** (3).

Si durante el ingreso de la información en cada una de las etapas fue digitando la opción completar para guardar los datos digitados en el sistema, no podrá realizar la función completar desde este menú (ver página 28 de este documento).

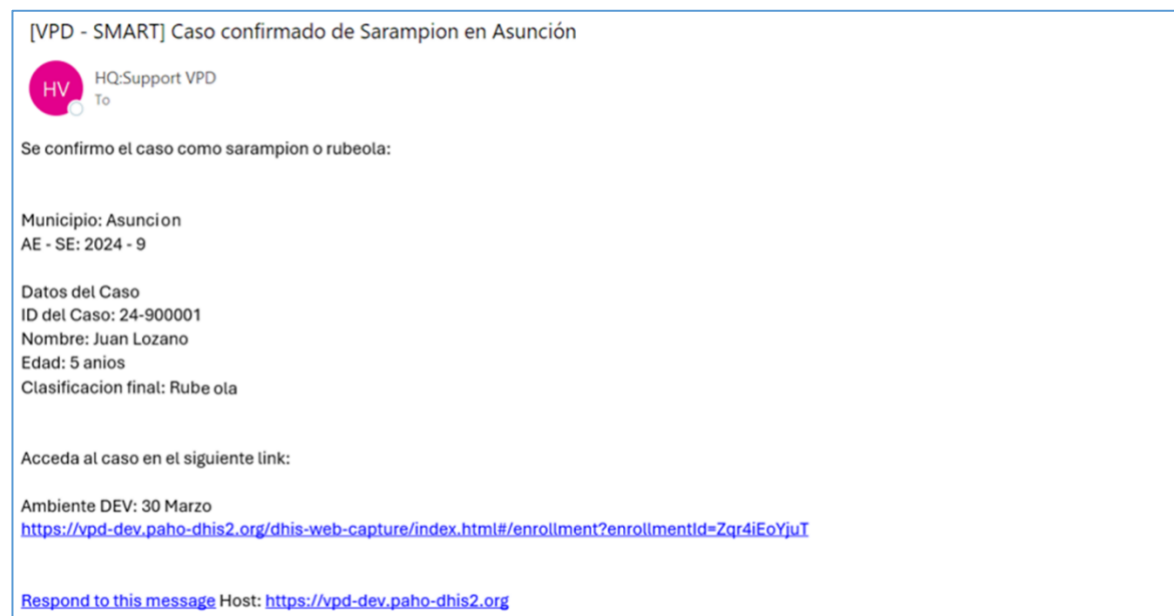
15. Configuración y gestión de alertas en VPD-SMART

Las alertas del sistema VPD-SMART consisten en notificaciones automáticas enviadas por correo electrónico a personas previamente designadas, con el objetivo de informar de manera oportuna situaciones críticas relacionadas con la vigilancia epidemiológica de SR. Estas alertas se activan ante eventos específicos definidos por el país, como la confirmación de un caso de sarampión o la clasificación de un caso como descartado sin un criterio válido de descarte.

Las condiciones que determinan qué situaciones serán consideradas como ‘alerta’ deben establecerse en la fase de implementación del sistema.

Para la correcta configuración de la emisión de estas notificaciones, es fundamental definir la frecuencia con la que se enviarán, evaluar la relevancia de los temas que ameritan generar una alerta y garantizar que las personas receptoras tengan la capacidad y la autoridad necesarias para tomar decisiones o acciones inmediatas frente a la situación reportada.

La imagen hace referencia a un correo tipo que enviado ante la detección de un caso confirmado rubéola.



16. Borrar caché dentro de VPD-SMART

El caché corresponde a una memoria temporal donde los programas y aplicaciones en línea almacenan de manera automática ciertos archivos, datos o configuraciones con el propósito de agilizar su funcionamiento. Gracias a este mecanismo, el sistema no requiere descargar nuevamente toda la información cada vez que se accede, lo que permite una carga más rápida y eficiente de los contenidos.

No obstante, en algunas circunstancias resulta necesario borrar el caché. Esto se debe a que los datos almacenados pueden quedar desactualizados, generar errores de visualización o funcionamiento, ocasionar conflictos con versiones más recientes del sistema o incluso ocupar espacio innecesario en el dispositivo. Al eliminar el caché, el

programa se ve obligado a descargar la información directamente desde el servidor, garantizando así que se muestre la versión más reciente, completa y libre de errores.